ANÁLISIS DE CASO

Morbilidad materna extrema

SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

Dra. Sharon Acuña - Ginecoobstetra
Karent Tatiana Rivera - Interna Ginecología

Preeclampsia

18/10/2025

"Dolor bajo y estoy sangrado desde ayer"

Paciente de 16 años con embarazo de 37.6 semanas quien asiste por cuadro clínico de 16 horas de evolución caracterizado por actividad uterina irregular , de intensidad 4/10 de 12 hrs de evolución, refiere movimientos fetales, niega sintomas de vasoespasmo como cefalea, tinnitus, epigastralgia o fosfenos.

- **Hipertension gestacional preeclampsia severa ?**

Examen físico

G/U: Globoso por útero grávido, au: 33 cm, feto en presentación cefálica dorso izquierdo movimientos fetales: presentes, sin dinamica uterina palpable, fetocardia 134 audible por la madre genitourinario: genitales femeninos normoconfigurados, vagina normotensa normoelástica, cuello posterior largo de 1 cm -2 membranas integras, no sangrado, no amniorrea, abundante leucorrea blanquecina fetida, grumosa.

Diagnósticos

- PACIENTE DE 16 AÑOS G1P0 CON DIAGNÓSTICO DE:
- EMBARAZO DE 37.4 SEMANAS POR ECOGRAFÍA DE SEGUNDO TRIMESTRE
- FETO UNICO VIVO - CEFALICO PFE E 13/10/2025 PLACENTA ANTERIOR GRADO II DE 37.3 MM ILA DE 10.6
- PEF 2806 P 25-
- THA E A CLASIFICAR - (HIPERTENSION GESTACIONAL PREECLAMPSIA SEVERA)
- PREPARTO
- PESO ADECUADO EDAD GESTACIONAL ESCALA DE ATALAH
- RIESGO OBSTÉTRICO: ALTO
- - PRIMI GESTANTE
- - ADOLESCENTE
- RIESGO TROMBOEMBÓLICO BAJO
- RIESGO DE HEMORRAGIA POSPARTO: MODERADO
- RIESGO PSICOSOCIAL: BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO 2 PUNTOS
- DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: ADECUADO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA 27 IMC
- RIESGO PARA PREECLAMPSIA: ALTO ** RECALCULADO
- RIESGO DE DEPRESIÓN POSPARTO BAJO
- PLANIFICACIÓN FAMILIAR POST PARTO IMPLANTE SUBDÉRMICO
- ASA NO
- CALCIO SI

- Hospitalizar en sala de parto
- Dieta normal
- lactato de ringer 500 cc/h
- Nifedipino 30 mg vo cada 12 hrs

>>>

- **Monitoria fetal ahora**
- **SS// Perfil de severidad tiempos treponema, VIH, toxoplasma IGM**
- **Curva de ta cad 15 minutos por 2 hrs**
- **Vigilar síntomas de vasoespasmo**
- **Fetocardia intermitente**
- **Csv*ac**

18/10/2025

- Se recibe llamado de enfermería paciente con cifras tensionales de 150/100 se indica ajuste de antihipertensivo oral a metoprolol 50 mg vo cada 12 horas se continúa vigilancia estricta.

Paraclínicos

- MONITORIA FETAL: 21+35
- LÍNEA DE BASE: 145 VARIABILIDAD: MODERADA ACELERACIONES: PRESENTES DESACELERACIONES: AUSENTES MOVIMIENTOS FETALES: POSITIVOS PTC SATISFACTORIA NEGATIVA CATEGORIA ACOG 1
- PERFIL TOXEMICO
- PT 7.4 INR 0.65 PTT 18.7 TGP 17.1 TGO 25.5 LDH 528.6 BILIRRUBINAS TOTAL 0.4 DIRECTA 0.2 INDIRECTA 0.20
- CREATININA 1.09 BUN 9.6
- RELACIÓN PROTEINAS 107.8/ CREATININA 88.89 : 1.21 POSITIVO
- UROANÁLISIS PROTEÍNAS 100 NORMAL
- HEMOGRAMA LEU 8.390 HB 13.2 HMT 39.2 PLAQ 207.000

- DIETA NORMAL
- LR 100CC/ H IV
- NIFEDIPINO 30 MG VO CADA 6 HRS
- METOPROLOL 50 MG VO CADA 12 HORAS CONTINUAR TRABAJO DE PARTO
- CONTROL ACTIVIDAD UTERINA, MONITORIA FETAL, TACTO VAGINAL

19/10/2025

- PACIENTE DE 16 AÑOS EN SEGUIMIENTO DE SU TRABAJO DE PARTO, CON CIFRAS TENSIONALES DADO INGRESO EN ESTADIO 1 . REFIERE CUADRO CLÍNICO ACTIVIDAD UTERINA UNA CADA 15 MINUTOS CON SIGNOS VITALES TA 140/100 FC 95 FR 19 SAO2 95 %

Analisis

CON RIESGO MEOWS BAJO RIESGO 3 PUNTOS CON RIESGO BAJO BAJO MONITORIZACIÓN CADA HORA EN LA QUE SE EVIDENCIA ACTIVIDAD UTERINA REGULAR EN TRABAJO DE PARTO FASE LATENTE SE COMENTA CON GINECOLOGO DE TURNO QUIEN INDICÓ PACIENTE NO CURSA CON CRISIS Y SE AJUSTA METOPROLOL EN EL MOMENTO SIN SÍNTOMAS DE VASOESPASMO.

PACIENTE DE 16 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS ANOTADOS EN SEGUIMIENTO DE SU TRABAJO DE PARTO. CON SIGNOS VITALES TA 130/ 71 FC 75 FR 17 SAT 95 %.

PACIENTE DE 16 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS

- PARTO VAGINAL EUTOCICO
- RECIÉN NACIDO SEXO MASCULINO A TÉRMINO PESO 3000 G, TALLA 50 CM, PC 34 CM, PT 31 CM, PA 31 CM. APGAR 8/9/10
- G1P1V1

25/10/2025

INGRESO A URGENCIAS - (EGRESO HACE 3 DÍAS)

PACIENTE DE 16 AÑOS EN PUERPERIO MEDIATO PARTO EUTOCICO VAGINAL DEL 19/10/2025 A LAS 13+15 PM SIN COMPLICACIONES CON ANTECEDENTE DE PREECLAMPSIA SIN CRITERIOS DE SEVERIDAD EN MANEJO AMBULATORIO CON METROPOLL Y NIFEDIPINO, QUIEN CONSULTÓ POR CUADRO DE LIPOTIMIA (REFIERE PERDIDA DE LA CONCIENCIA 3 SEGUNDOS), POSTERIORMENTE CEFALEA LEVE.

PARACLÍNICOS CON PROTEINURIA PREVIAMENTE POSITIVA CUANDO SE REALIZÓ DX DE PREECLAMPSIA EN EL TRABAJO DE PARTO), SIGNOS VITALES AHORA NORMALES TA 116/70 MMHG FC 75 LPM FR 17 RPM SAO2 95% FIO2 0.21, A LA REVALORACIÓN PACIENTE MANIFIESTA SENTIRSE BIEN, ASINTOMATICA, SE DA EGRESO.

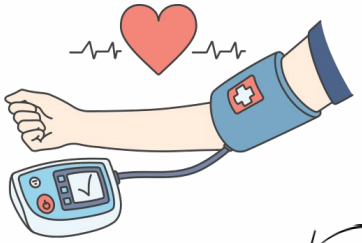


G1P1
PUERPERIO MEDIATO PARTO EUTOCICO VAGINAL DEL 19/10/2025 A LAS 13+15
CEFALEA RESUELTA
PREECLAMPSIA SIN CRITERIOS DE SEVERIDAD
HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA EN TRATAMIENTO

Código Rojo

11/10/2025

- Paciente de 27 años g1 con embarazo de 40 semanas por ecografía de i trimestre; consulta por edad gestacional, refiere sentirse bien, asintomatica, niega dinamica uterina, niega pérdidas vaginales, asintomatica para vasoespasmo, niega cefalea, niega fosfenos, niega tinnitus, niega epigastralgia, niega edemas u otros sintomas.



ANTECEDENTES:

PATOLÓGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: NIEGA
FARMACOLÓGICOS: NAPROXENO Y DIPIRONA
ALÉRGICOS: NIEGA
HOSPITALARIOS: NIEGA
TÓXICO: NIEGA CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS, CIGARRILLO O LICOR
FAMILIARES: MADRE Y ABUELO HTA Y DM
ANTECEDENTE DE PREECLAMPSIA MADRE O HERMANA NIEGA
HISTORIA DE CÁNCER HEREDOFAMILIAR NIEGA

Se hospitaliza por edad gestacional para iniciar proceso de inducción del trabajo de parto, cuenta con ecografía obstétrica del 03/09/2025 feto único, cefalico, longitudinal, dorso derecho, placenta corporal posterior g ii, ila 17 cc, pfe 2640 gr, p 76%, emb 34.4 semanas, se decide iniciar inducción con oxitocina.

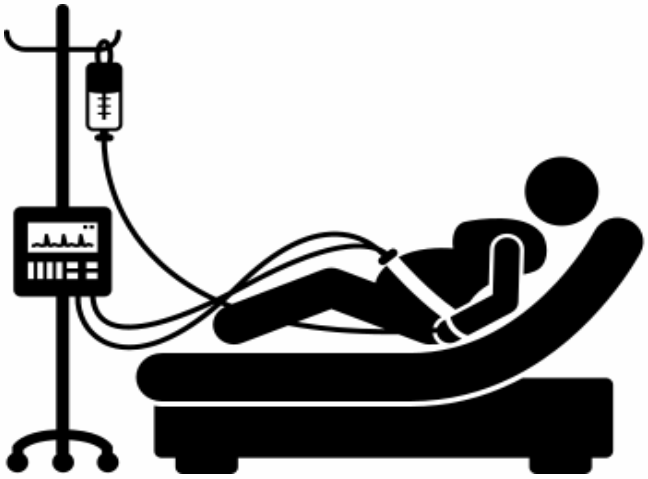


12/10/2025

PACIENTE EN POSTARTO VAGINAL EUTOCICO DLE 12/12/2025 A LAS 19+10 , SE RECIBE LLAMADO DE MÉDICO GENERAL CON SANGRADO UTERINO, CÓDIGO ROJO 19+25.

PACIENTE 19+25 PACIENTE CON SANGRADO MAYOR >500 CC CON ÍNDICE DE CHOQUE 0.8 SIN TONO UTERINO.

- Activación de código rojo.
- **Lista de Chequeo - ESTRATEGIA ISABEL**
- Ginecólogo realiza revisión uterina con evidencia de atonía uterina.



ACTIVACIÓN DE CÓDIGO ROJO, TOMA DE DOS ACCESOS VENOSOS, MONITORIZACIÓN DE PACIENTE, ADMINISTRACIÓN DE MANEJO FARMACOLÓGICO (OXITOCINA, METHERGIN #2 DOSIS Y MISOPROSTOL ORAL (600 MCG)) + JUNTO REANIMACION HIDRICA SIMULTÁNEAMENTE CON MASAJE BIMANUAL, POSTERIORMENTE SIENDO A LAS 19+45.

PACIENTE CON SIGNOS VITALES 136 /76 MMHG FC 138 FR 7 T 36.5 SAT 95 % ÍNDICE DE CHOQUE DE 1. 0,

SANGRADO VAGINAL ESCASO, UTERO TONICO.

Previa asepsia y antisepsia cambio de guantes estériles se revisa canal vaginal se realiza episiorrafia con cromado 2-0 con técnica usual sin complicaciones, se deja compresa #1 en canal de parto se verifica hemostasia y tono uterino adecuado , tacto rectal normal al final del procedimiento, se indica vigilancia en unidad de cuidado intermedio por 24 hrs, se solicita valoración, se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

MONITORIZACIÓN CONTINUA
NVO
LR BOLÓ DE 1000 CC CONTINUAR A 100 CC/ H
LACTATO DE RINGER 500CC + OXITOCINA 40 UI PASAR A 120 CC/H IV
CEFAZOLINA 2 GR IV AHORA CONTINUAR 1 GR IV CADA 6 HRS
-ACIDO TRANEXAMICO 1 GR IV AHOR A
-METILERGOMETRINA # 2 DOSIS APLICADAS ÚLTIMA 17+40
-MISOPROSTOL 600 MG VO DOSIS ÚNICA
MEPERIDINA 50 MG IM
VITAMINA k 1MG (AL RECIÉN NACIDO)
LIDOCAÍNA SIN EPI AL 2% 2 AMPOLLAS
SSN 100 CC PARA DILUCIONES
CATGUT CROMADO 2-0 CT1
VIGILAR TONO UTERINO Y SANGRADO GENITAL, REALIZAR MASAJE UTERINO
SS// GASES ARTERIALES, HEMOGRAM TIEMPOS, FIBRINÓGENO
SS// VAL POR CUIDADO INTERMEDIO





12/10/2025

Paciente en puerperio mediato de posparto vaginal,con hemorragia posparto secundaria a atonia uterina, que requirió manejo médico farmacológico + masaje bimanual, en el momento en aceptable estado general, con taquicardia, febril (seduncadiro a administracion de misoprostol) normotensa sin signos de hipoperfusión ni de vasoespasmo, con moderada modulación del dolor, uterotónico infraumbilical, sangrado vaginal leve, con compresa con estigmas de sangrado .

PUERPERIO MEDIATO .
PACIENTE DE 27 AÑOS G1 P1V1 CON DIAGNÓSTICOS
POSPARTO VAGINAL DEL 12/10/2025
HEMORRAGIA POSPARTO - ATONÍA UTERINA - SANGRADO DE 700 CC
RN MASCULINO A TÉRMINO
ALTO RIESGO OBSTÉTRICO
ALTO RIESGO OBSTÉTRICO PRIMIGESTANTE
ALTO RIESGO DE HPP
MODERADO RIESGO TROMBOEMBÓLICO
BAJO RIESGO DE PREECLAMPSIA
BAJO RIESGO PSICOSOCIAL (HYH 1 PUNTO
BAJO RIESGO DE DEPRESIÓN POSPARTO
ESCALA DE ALERTA TEMPRANA 3 PUNTOS
PLANIFICACIÓN POSPARTO : POMEROY



Código rojo extrainstitucional

FI: 5/10/2025

- **Paciente de 29 años G6P3A3V3 con embarazo de 20+5 semanas por eco**
- **Remitida de Chitaraque por Aborto incompleto**
- **Cuadro clínico de 5 hrs de evolución consistente en dolor pélvico con posterior expulsión de producto. Comenta episodio de sangrado vaginal escaso desde Septiembre**

- **HC de primer nivel: (5+10 am).** No inicio de manejo AB a pesar de identificar placenta y cordón umbilical en canal de parto. Manejo con hidroterapia 500 cc.
- **Antecedentes:** Sangrado I trimestre, Hospitalización en Agosto (IVU) y Septiembre (Hemorragia II trimestre) + anemia severa (transfusión)





29 AÑOS

G6P3A3V3

Analisis: paciente en aceptable estado general, palidez mucocutanea, sin signos de bajo gasto.

- **Qsofa 0 puntos**
- **Escala de alerta temprana 0 puntos**
- **IC 0.8**

Examen fisico: Abdomen con dolor moderado,uterotónico, durante valoracion realiza expulsión de placenta

Ecografia TV: sin evidencia de restos ovulares, útero y anexos normales, sangrado vaginal escaso.

Paciente comenta no seguimiento desde última hospitalización, con sangrado vaginal crónico desde el **6/9/2025.**



29 AÑOS

G6P3A3V3

Alto riesgo de infección por parto domiciliario: se indica manejo **antibiotico profilactico,** exámenes de ingreso, estudio patológico de feto y placenta,

1. **ABORTO ESPONTANEO COMPLETO: GESTACION DE 20.5 SEM**
2. **RIESGO OBSTÉTRICO:ALTO**
3. **PERDIDA GESTACIONAL RECURRENTE**
4. **RURAL DISPERSO**
5. **POBRE CONTROL PRENATAL**
6. **PRIMIPATERNIDAD**
7. **PERIODO INTERGENÉSICO CORTO RIESGO**
8. **RIESGO DE HEMORRAGIA POSPARTO MODERADO**
9. **RIESGO PSICOSOCIAL: ALTO**
10. **DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: SOBREPESO PARA EDAD GESTACIONAL**
11. **RIESGO PARA PREECLAMPSIA: MODERADO**
12. **RIESGO DE SEPSIS: Q SOFA 0 PUNTOS**
13. **PLANIFICACIÓN FAMILIAR POST PARTO : POMEROY ESCALA TEMPRANA MEOWS : 0 PUNTOS**



29 AÑOS

G6P3A3V3

Manejo inicial:

- Hospitalización
- Monitorizacion continua
- Dieta liquida
- L. ringer 100 cc/ h
- Clindamicina 600 mg IV cada 6 hrs
- Gentamicina 240 mg IV dia
- Diclofenaco 75 mg IM ahora
- Omeprazol 20 mg vVO
- Medias antiembolicas
- Vigilar sangrado.

Control paraclínico y clínico

- 05/07/2025: LEU 12.67 NEU 852 LIN 11.3 HB 5.9 HTC 19.2 PLT 387.000

ANEMIA SEVERA CÓDIGO ROJO EXTRAINSTITUCIONAL



29 AÑOS

G6P3A3V3

ANEMIA SEVERA CÓDIGO ROJO EXTRAINSTITUCIONAL

Manejo inicial:

- Transfundir 3 UGRE + 1 plasma fresco congelado

Control paraclínico y clínico

- 07/10/2025 LEUCOS 7710 HB 8.7 HMT 27.4 PLAQ 317000

SE REALIZA POMEROY COMO PNF (09/10/2025)

10/10/2025

Paciente en POP dia 1, sin SIRS, antibioticoterapia dia 5/5. Alerta, afebril, hidratada, clínica y hemodinámicamente estable

EGRESO

- Cita PNF en 1 mes
- Uso preservativo 3 meses
- Cita control G/O en 10 días con retiro de puntos
- ACTM 1 gr c/ 6 horas por 5 días
- Gentamicina 160 mg IM dia por 3 dias
- Uso medias compresión
- Signos de alarma y recomendaciones

Gracias

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!